Hôpitaux de Toulouse

GHT

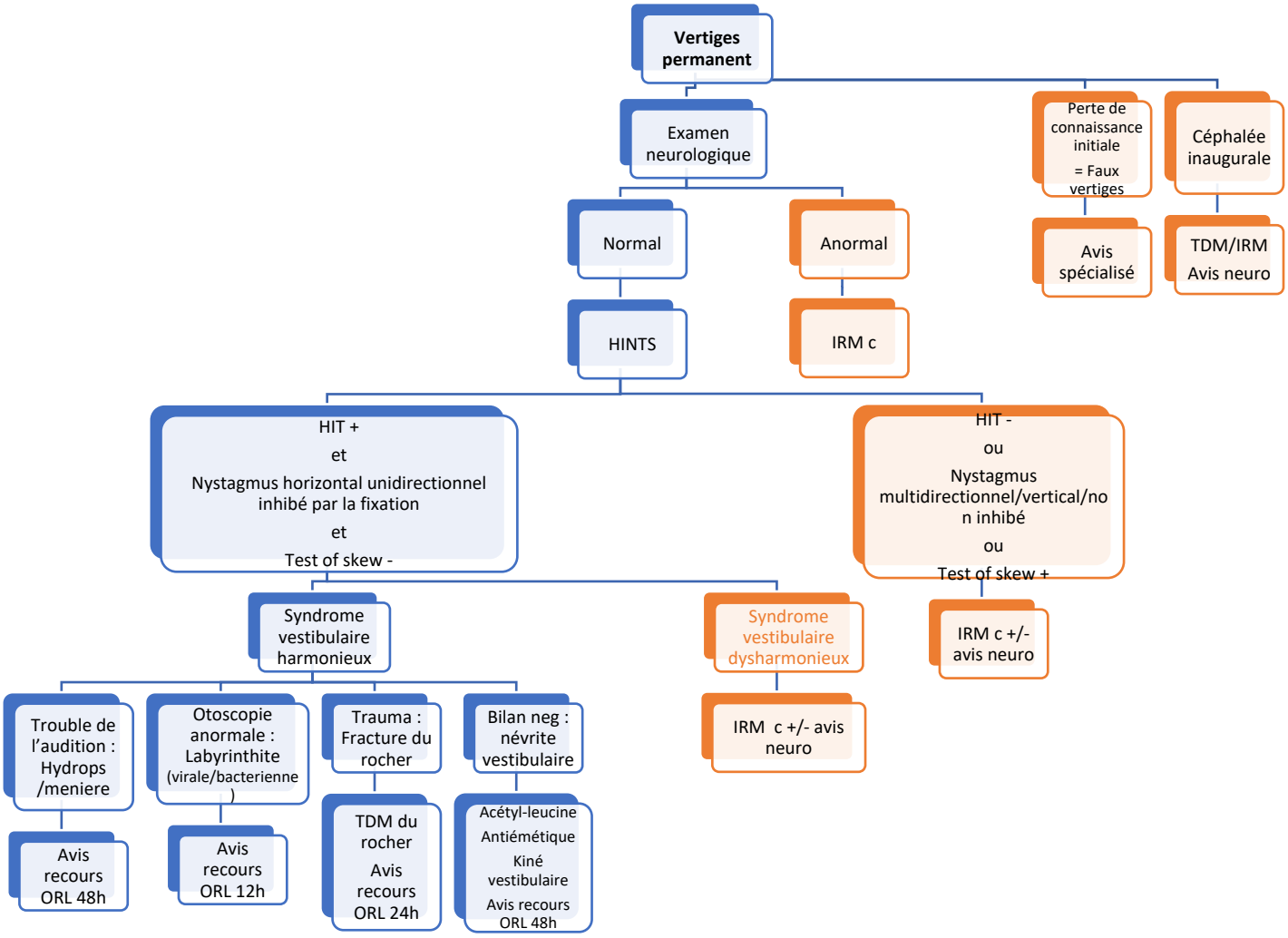
Protocole clinique

Prise en charge des vertiges aux urgences

Version : 1
Date d'application : 03/08/2023
Indexation : PEC-PCLI-017

I - OBJET DU DOCUMENT :

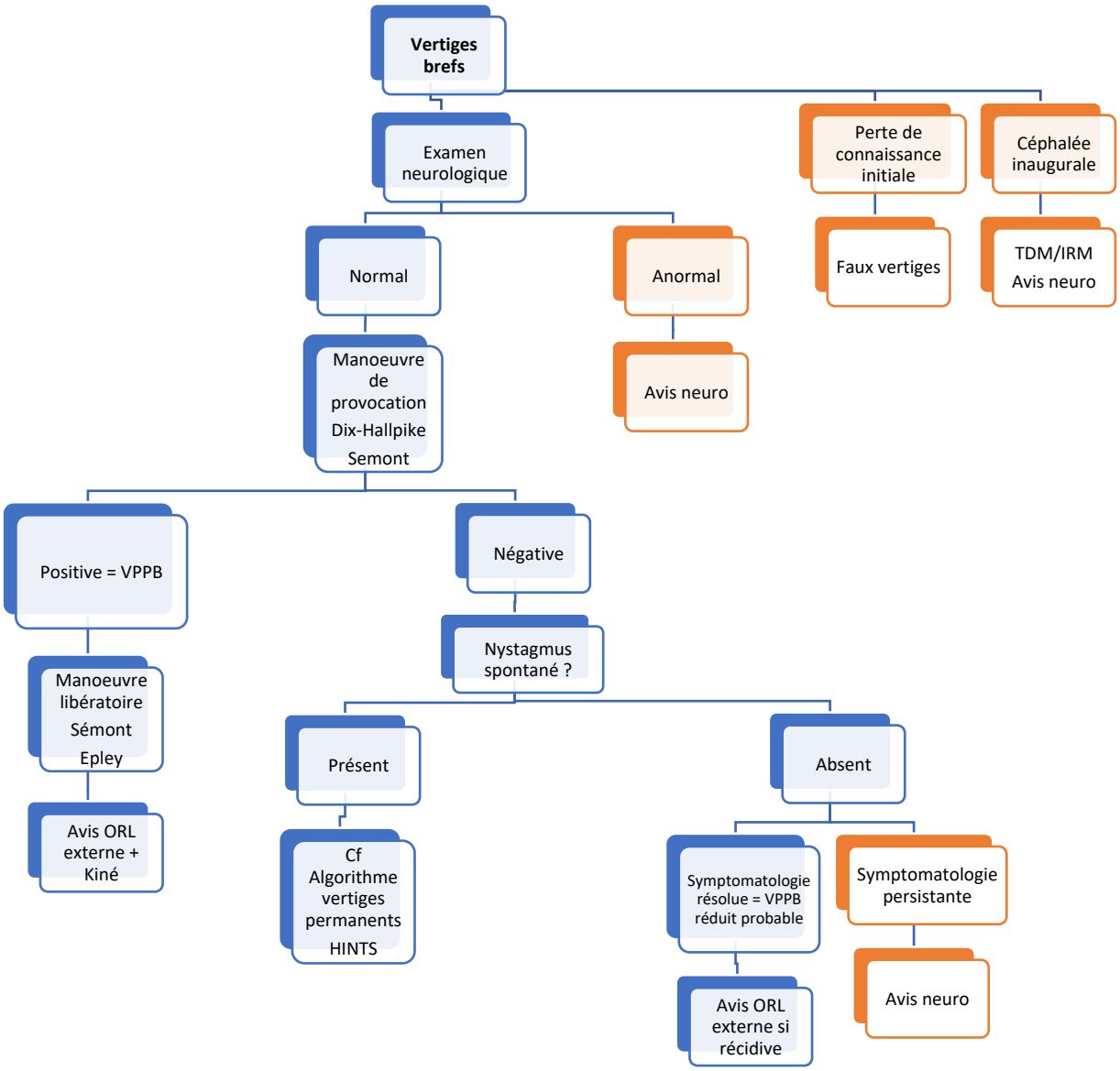
Prise en charge des vertiges aux urgences



Rédigé par : Dr K. OUDRHIRI
Vérifié par : Dr Y. GALLOIS
Approuvé par : Dr CH.HOUZE-CERFON

Prise en charge des vertiges aux urgences

Version : 1
Date d'application : 03/08/2023
Indexation : PEC-PCLI-017



Rédigé par : Dr K. OUDRHIRI
Vérifié par : Dr Y. GALLOIS
Approuvé par : Dr CH.HOUZE-CERFON

Prise en charge des vertiges aux urgences

Version : 1
Date d'application : 03/08/2023
Indexation : PEC-PCLI-017

1. Eléments d'interrogatoire non-ORL

CÉPHALÉES INAUGURALES	PERTE DE CONNAISSANCE
Signes neurologiques	Faux vertiges = les plus fréquents!
Evoquent une cause centrale	• Syncope vaso-vagale • Hypotension orthostatique • Trouble du rythme ou de la conduction cardiaque • Hypertension artérielle pulmonaire • Troubles de la marche

2. HINTS

Vertige continu	Potentiellement central (UN seul signe suffit)	Potentiellement périphérique (TOUS les signes présents)
HIT	Pas de saccade	Saccade de refixation
Nystagmus	Multidirectionnel Pas de nystagmus Vertical inferieur	Unidirectionnel horizontal
Skew deviation test	Déviation verticale	Pas de déviation

3. Syndrome vestibulaire harmonieux /Disharmonieux :

Syndrome vestibulaire harmonieux (ex : Droit) →Etiologie périphérique

- Déviation segmentaire/posturale homolatérale (Droit)
- Nystagmus (phase rapide) controlatéral (Gauche)
- Déviation lente des yeux homolatérale (Droit)

4. VPPB : Manœuvres

- Manœuvre de Dix Hallpike : teste le canal postérieur du même côté que la tête est tournée
- Manœuvre de Semont : libère le canal post (efficace dans 80%)

Rédigé par : Dr K. OUDRHIRI
Vérifié par : Dr Y. GALLOIS
Approuvé par : Dr CH.HOUZE-CERFON

- Manœuvre d'Epley

5. Migraine vestibulaire

Il s'agit de vertiges de plusieurs heures avec nausées et vomissements, photophobie et phonophobie, parfois accompagnés de céphalées. On remarque des prodromes à type de malaise. On remarque des antécédents personnels et familiaux de migraine.

Migraine vestibulaire certaine
A. Symptômes vestibulaires épisodiques (spontanés ou positionnels) de sévérité au moins modérée (interfèrent mais n'empêchent pas les activités quotidiennes) B. Histoire actuelle ou passée de migraines typiques selon la nomenclature internationale C. Association d'un ou des symptômes migraineux suivants à >2 épisodes de vertiges : céphalée migraineuse, photophobie, phonophobie, aura visuelle ou autre D. Autres causes éliminées par des investigations appropriées
Migraine vestibulaire probable
A. Symptômes vestibulaires épisodiques (spontanés ou positionnels) de sévérité au moins modérée (interfèrent mais n'empêchent pas les activités quotidiennes) B. L'un des critères suivants : a. Histoire actuelle ou passée de migraines typiques selon la nomenclature internationale b. Association de symptômes migraineux durant les vertiges c. Facteur précipitant migraineux induisant des vertiges dans plus de 50% des attaques d. Réponse aux traitements antimigraineux dans plus de 50% des attaques de vertiges C. Autres causes éliminées par des investigations appropriées

Neuhauser et al, Neurology, 2001

6. Traitement symptomatique

- Un repos au lit
- Traitement médicamenteux :
  - antivertigineux :
    - antivertigineux majeurs sédatifs et vestibuloplégiques : benzodiazépines, chlorhydrate de méclozine (AGYRAX) ;
    - antivertigineux mineurs peu sédatifs (compensateurs et préventifs) : acétyl-leucine (TANGANIL), piracétam(NOOTROPYL), bétahistine (LECTIL) ;
  - antiémétiques :
    - neuroleptiques : métopimazine (VOGALENE), métoclopramide (PRIMPERAN), antagoniste 5-HT3 (ONDANSETRON) ;
  - antimigraineux (vertiges migraineux) : flunarizine

En cas d'inefficacité du traitement ambulatoire : hospitalisation (appel de l'interne d'ORL obligatoire), acétyl leucine, +/-corticoïdes.

Rédigé par : Dr K. OUDRHIRI
Vérifié par : Dr Y. GALLOIS
Approuvé par : Dr CH.HOUZE-CERFON

Prise en charge des vertiges aux urgences

Contacts :

Semaine 8h-18h : Interne d'ORL 46298

Nuit, Week end, jours fériés : Service : 72314

Avis de l'interne de garde de garde devant un tableau atypique ou une demande d'hospitalisation. Les vertiges ne peuvent pas être adressé directement depuis l'accueil vers les « urgences ORL », se sont des « consultations post-urgences » sur **RDV le lendemain**.

II - DOMAINE D'APPLICATION :
Service des Urgences de Purpan et Rangueil

III- PERSONNES AUTORISEES (à compléter par le responsable médical signant le protocole) en fonction des références réglementaires.

A prescrire : X Médecin OU A entreprendre ○ IDE, ○ IADE, ○ Sage-femme, ○ Manipulateur en électroradiologie, ○ Masseurs kinésithérapeutes

A administrer : X IDE, ○ IADE, ○ Sage-femme, ○ Manipulateur en électroradiologie, ○ Masseurs kinésithérapeutes

IV-DOCUMENT(S) DE REFERENCE :

V-DOCUMENTS ASSOCIES :

VI – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS :

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS		
N° version	Date	Nature des modifications
1	07/2023	Création

ANNEE PREVISONNELLE DE REVISION : 2026

Rédigé par : Dr K. OUDRHIRI
Vérifié par : Dr Y. GALLOIS
Approuvé par : Dr CH.HOUZE-CERFON